التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

حين صار الإجراء الصحيح هو الخيار الجاهز في النظام، فعله عدد أكبر من الناس.

أما النتائج فلم تتغيّر دائمًا.

هذا ما تقوله أربع تجارب عشوائية نُشرت بين عامي 2023 و2026، وكلها في الرعاية الصحية.

← اسحب للمتابعة

التجربة الأولى

ماذا تغيّر في أحد عشر مستشفى؟

في الرعاية المعتادة، لا يحصل المريض على استشارة الرعاية التلطيفية إلا إذا قرّر الطبيب طلبها.

ثم صار طلبها يُسجَّل تلقائيًا لكل مريض في الخامسة والستين فأكثر مصاب بانسداد رئوي مزمن متقدم أو خرف أو فشل كلوي، وبقي للطبيب أن يلغيه. ولم يزد عدد العاملين في الرعاية التلطيفية.

الرعاية التلطيفية رعاية تخفّف الأعراض، وتساعد المريض وأسرته على اتخاذ قرارات العلاج في المرض الشديد.

النتائج

ارتفعت الاستشارات، وبقيت مدة البقاء كما هي

43.9%

من المرضى حصلوا على الاستشارة حين صارت تلقائية، مقابل 16.6% في الرعاية المعتادة.

3.4

أيام بعد الدخول في المتوسط جاءت فيها الاستشارة، بدل 4.6 أيام.

لكن مدة البقاء في المستشفى، وهي الهدف الأول للدراسة، لم تتغيّر. وقد شمل التحليل 24,065 مريضًا.

التجربة الثانية

علاج يبدأ للجميع، ولكلٍّ أن يرفضه

في مستشفى جامعي أمريكي، وُزّع 1000 مريض مدخّن على طريقتين: علاج لا يُقدَّم إلا لمن يطلبه، وعلاج يبدأ تلقائيًا ومن شاء رفضه.

60%

استخدموا دواء الإقلاع بعد الخروج حين بدأ العلاج تلقائيًا، مقابل 34%.

89%

أكملوا مكالمة إرشاد واحدة على الأقل، مقابل 37%.

وبعد شهر أقلع 22% مقابل 16%، ثم تقارب الفريقان بعد ستة أشهر: 19% مقابل 18%.

Richter et al., JAMA Intern Med, 2023

لماذا يحدث ذلك؟

الخيار الجاهز لا يكلّف صاحبه شيئًا، أما الخروج عليه فيحتاج إلى قرار

وكثير من الناس يقرؤون الخيار الجاهز توصيةً ضمنية ممن صمّم النظام.

ومعنى ذلك أن من يصمّم النموذج أو قائمة الطلبات يقرّر، وإن لم يقصد، ما سيفعله أكثر من يستخدمونها.

هذا تفسير من الكاتب، لا نتيجة قاستها التجربتان.

ولا ينجح الخيار الجاهز دائمًا

الخيار الذي يمكن تجاوزه قد يتجاوزه أكثر الناس

21%

فقط من مرضى الجراحة حصلوا على الوصفة الجاهزة للمسكّن، وكتب الجراحون للباقين وصفاتهم بأنفسهم، فلم تتغيّر الكمية الإجمالية.

12

وحدة عناية مركزة جرّبت إعدادًا جاهزًا لجهاز التنفس، فلم يرتفع الالتزام ارتفاعًا يُعتدّ به، وتفاوت الأثر بين الوحدات.

Zhang, Ann Surg 2025 · Kerlin, Implement Sci 2026

TAMAYUZ 10X

مستخلص من الدراسات

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

أن يسأل: ما الذي يحدث تلقائيًا في نماذجنا وأنظمتنا إذا لم يختر أحد شيئًا؟

2

أن يجعل الإجراء الموصى به هو الخيار الجاهز، ويضعه في الطريق الذي يسلكه الناس فعلًا، مع إبقاء الرفض سهلًا.

3

أن يقيس أمرين: هل استُخدم الخيار الجاهز، وهل تغيّرت النتيجة.

> **أيّ خيار جاهز في أنظمتك يقرّر اليوم ما يفعله فريقك، دون أن ينتبه إليه أحد؟**

حدود هذه الأدلة

التجارب الأربع كلها في الرعاية الصحية، واثنتان منها في مستشفى أو مركز واحد.

بيانات تجربة الرعاية التلطيفية جُمعت بين عامي 2016 و2018.

لم تشمل أيٌّ منها مؤسسات عربية، وتعميم الفكرة على قطاعات أخرى استنتاج.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Courtright, K. R., et al. (2024). Default Palliative Care Consultation for Seriously Ill Hospitalized Patients. *JAMA*, 331(3), 224–232.

[2] Richter, K. P., et al. (2023). The Effects of Opt-out vs Opt-in Tobacco Treatment on Engagement, Cessation, and Costs. *JAMA Internal Medicine*, 183(4), 331–339.

[3] Zhang, I. Y., et al. (2025). Prescription Default Nudges for Opioid Reduction after Major Surgery (NORMS). *Annals of Surgery*.

[4] Kerlin, M. P., et al. (2026). Nudging implementation of low tidal volume ventilation. *Implementation Science*, 21(1), 40.

المقال الكامل: tamayuz10x.com/article-oe-evidence-defaults-shape-practice.html